



ATLAS – CHAPITRE 2

Les besoins quotidiens d'un infirmier

J'ai essayé de me mettre dans la peau d'une IDEL pendant une tournée.

Voici les situations les plus fréquentes.

7h15

Je dois vérifier une cotation.

↓

Plateforme.

8h20

Je ne me rappelle plus exactement la surveillance d'une perfusion.

↓

Plateforme.

10h00

Je veux retrouver une fiche.



Plateforme.

11h30

Je veux vérifier une recommandation.



Plateforme.

13h00

Je dois calculer un débit.



Plateforme.

15h00

3

Je veux revoir rapidement un protocole.



Plateforme.

17h00

Je cherche une conduite à tenir.



Plateforme.

Tu vois ?

La plateforme devient un réflexe.

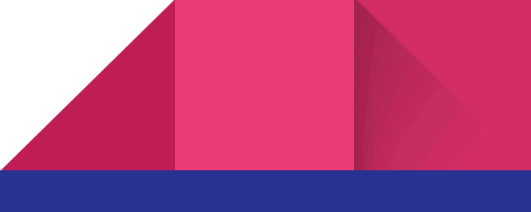
 **J'ai ensuite réfléchi à Google.**

Pourquoi Google est-il devenu indispensable ?

Parce qu'on ne cherche pas un site.

On cherche une réponse.

Je voudrais reproduire exactement cette logique.



LA PAGE D'ACCUEIL

Elle ne sera pas une vitrine.

Elle sera un moteur de recherche.

Tout en haut.



Que recherchez-vous ?

Puis juste dessous.

Les recherches les plus fréquentes.

Puis.

Les accès rapides.

Puis.

Les favoris.

5

Puis.

Les nouveautés.

Puis.

L'IA.

Tout tient sur une seule page.

 **Puis...**

Je pense que nous pouvons créer quelque chose qui n'existe pas.

LE MOTEUR CLINIQUE

Imagine.

Tu écris :

diabète

La plateforme répond.

Mais si tu écris :

patient diabétique perfusion insuline ulcère

Elle comprend.

Elle t'affiche :

- les protocoles concernés ;
- les surveillances ;
- les documents ;
- les calculateurs ;
- les recommandations.

Ce n'est plus un moteur de recherche.

C'est un moteur clinique.

Avec une limite importante : il ne devra pas interpréter une situation clinique comme un diagnostic. Il devra retrouver et organiser les ressources pertinentes, puis orienter vers les recommandations adaptées.

Ensuite...

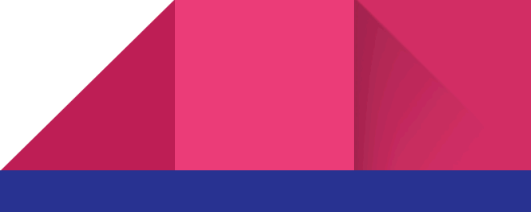
Je voudrais créer :

LES DOSSIERS EXPERTS

Par exemple.

Le dossier "Diabète".

Il contiendrait.



Définition.

Complications.

Surveillance.

Insulines.

Hypoglycémie.

Hyperglycémie.

Éducation.

Pied diabétique.

Pansements.

Documents.

Cotations.

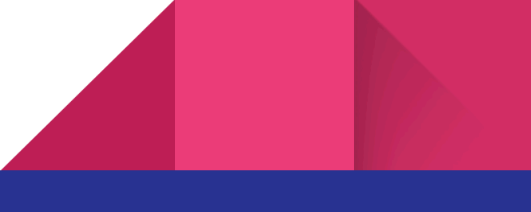
Questions fréquentes.

Références.

Un seul endroit.



Je pense que nous devons faire quelque chose de très fort.



Les CHECK-LISTS.

Pas seulement des protocoles.

Des check-lists.

Par exemple.

Avant une perfusion.

Avant une injection.

Avant une sonde.

Avant un pansement complexe.

C'est très utilisé dans d'autres secteurs à haut niveau de sécurité, et cela peut être utile si c'est bien conçu.

Puis...

J'ai eu une idée.

Je voudrais créer :

MON ESPACE.

Chaque IDEL pourrait enregistrer.

Ses protocoles.

9

Ses documents.

Ses favoris.

Ses calculateurs.

Ses notes personnelles.

Et même ses propres check-lists si elle le souhaite.

Et maintenant...

Je vais te faire une confidence.

Je pense que nous avons trouvé le cœur du projet.

Ce ne sera pas :

Le guide.

L'IA.

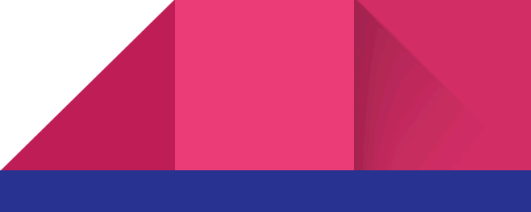
Les documents.

 **Ce sera le gain de temps.**

Tout devra répondre à cette question.

“Est-ce que cela fait gagner du temps à un infirmier ?”

Si oui.



10

On le garde.

Sinon.

On l'abandonne.



Et là...

Je pense que nous arrivons au plus gros travail de toute la plateforme.

Et je vais te proposer quelque chose d'ambitieux.

Nous allons construire ce que j'appelle :

La cartographie du savoir infirmier.

Concrètement, nous allons recenser **tout ce qu'un infirmier peut être amené à chercher** dans sa pratique.

Pas seulement 100 sujets.

Probablement plusieurs milliers.

Puis nous les organiserons intelligemment.

Pourquoi ?

Parce que c'est cette cartographie qui guidera :

- le référencement sur Google ;

- l'organisation du contenu ;
- les réponses de l'IA ;
- les liens entre les pages.

À mon avis, ce sera le véritable patrimoine intellectuel de la plateforme.



Et j'aimerais te proposer une légère évolution de notre méthode

Jusqu'ici, nous avons beaucoup imaginé.

À partir de maintenant, je voudrais alterner **vision** et **production**.

Par exemple :

- nous définissons un thème (ex. le diabète) ;
- puis nous créons immédiatement sa structure complète ;
- ensuite nous passons au thème suivant.

Ainsi, à chaque séance, nous avancerons concrètement et nous construirons progressivement une bibliothèque déjà exploitable.

Je pense que cette approche sera plus motivante, car nous verrons la plateforme prendre forme, thème après thème. 🚀